Auditoría de Uso Previsto (Intended Use) — DualisCheckUp

Fecha: 2026-10-15 · **Rama auditada:** `feat/phase-11-multi-profile` (incluye cambios sin commit) · **Alcance:** solo lectura de `mobile/`, `backend/`, `.planning/`, `.agents/`, `CLAUDE.md`.

> **Aviso:** esto no es asesoría legal ni regulatoria. Es un análisis técnico de producto contra el texto público de las normas citadas. Un consultor regulatorio (ANVISA / MDR / FDA) y un abogado de protección de datos deben confirmarlo antes del lanzamiento. Donde hay juicio propio lo marco como **[Juicio]**.

Normas en las que me apoyo

Región	Norma	Qué uso de ella
BR	ANVISA **RDC 657/2022** (SaMD)	Ámbito: software con finalidad médica (diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento de enfermedad). Excluye de su ámbito el software destinado a **bienestar** (verificar numeración exacta del artículo de exclusiones con el consultor).
BR	ANVISA **RDC 751/2022** (clasificación de dispositivos médicos, Clases I–IV)	Reglas de clasificación del Anexo I; el software que alimenta decisiones diagnósticas/terapéuticas o de urgencia cae en clases de riesgo intermedio/alto.
EU	**MDR 2017/745**, Art. 2(1), Art. 2(12) y **Anexo VIII Regla 11**	Software que da información para decisiones con fines diagnósticos/terapéuticos = IIa; si la decisión puede causar deterioro grave = IIb; muerte/daño irreversible = III. Art. 2(12): el uso previsto se deduce de etiquetado, instrucciones, **material promocional y documentación técnica**.
EU	**MDCG 2019-11** (cualificación y clasificación de software)	Árbol de decisión: (a) ¿realiza una acción sobre los datos distinta de almacenar/archivar/comunicar/búsqueda simple? (b) ¿es en beneficio de un paciente individual? (c) ¿finalidad médica del Art. 2(1)? Si sí → MDSW.
EU	**AI Act (Reg. 2024/1689)**	Si el producto es MDSW clase IIa+ sujeto a organismo notificado, el componente de IA pasa a ser de **alto riesgo** (Art. 6(1) + Anexo I). Motivo extra para quedarse en bienestar.

Región	Norma	Qué uso de ella
US	FDA **General Wellness: Policy for Low Risk Devices**	Categoría 1: mantener/estimular un estado general de salud **sin referencia a enfermedades o condiciones**. Categoría 2: estilo de vida saludable para reducir riesgo de enfermedades crónicas bien establecidas. Fuera de eso → no es wellness. (FDA revisó esta guía y la de CDS recientemente; confirmar versión vigente.)
US	FDA **Clinical Decision Support Software**	Los 4 criterios del 520(o)(1)(E) FD&C Act. El criterio 3 exige que el usuario sea **profesional de salud**: CDS orientado a pacientes/legos **no** queda excluido de la definición de dispositivo.
US	FDA **Policy for Device Software Functions and Mobile Medical Apps**	Lista de funciones bajo *enforcement discretion* (p. ej. apps que ayudan a autogestionar sin dar recomendaciones de tratamiento específicas; checklists de síntomas con consejo genérico de cuándo consultar). **[Juicio]**: es la única vía por la que el flujo actual podría tolerarse en US, y el bloque de emergencia/IA lo aleja de ella.
US	FTC **Health Breach Notification Rule** (16 CFR 318, enmienda 2024) + FTC Act §5	Apps de salud = vendor de PHR; "breach" incluye divulgación no autorizada (SDKs, IA de terceros). §5: afirmaciones de salud engañosas o sin sustento.
Stores	Apple **App Review Guideline 1.4.1** (+ 5.1.1/5.1.3)	Apps médicas que pueden dar datos inexactos se revisan con más rigor; deben divulgar metodología y, si hacen diagnóstico/tratamiento, acreditar autorización regulatoria. Datos de salud no pueden usarse para publicidad.
Stores	Google Play **Health apps policy** + Health apps declaration	Declarar la categoría; si no es dispositivo médico regulado, incluir disclaimer claro; afirmaciones médicas engañosas = rechazo.

---

1. Veredicto (5 líneas)

1. **Brasil — riesgo ALTO.** Tal como está, el producto encaja en la definición de SaMD de la RDC 657/2022 (prevención/triaje individual con disposición asistencial) y los propios Términos lo declaran "classificada conforme a RDC 657/2022"; por RDC 751/2022 probablemente Clase II–III **[Juicio]**.
2. **UE — riesgo ALTO.** Pasa los tres pasos del MDCG 2019-11 (procesa datos, por paciente individual, finalidad de triaje); por Regla 11 al menos **IIa**, con argumento fuerte para **IIb** porque decide "Emergência / Pronto Atendimento" **[Juicio]**; arrastra además el AI Act de alto riesgo.
3. **EE. UU. — riesgo MEDIO-ALTO.** No es General Wellness (nombra infarto, AVC, crisis suicida,

"emergência"); es CDS orientado a pacientes, que no cumple el criterio 3; la *enforcement discretion* para "symptom checkers" es discutible por la detección algorítmica de emergencias y la IA **[Juicio]**.

4. **Stores:** con el copy actual ("Triagem", "Resultado da Triagem", "Artigos Médicos", "classificação clínica") Apple 1.4.1 pedirá prueba de autorización regulatoria o rechazará.
5. **Driver único más grande:** la **disposición asistencial personalizada** (`intensidade × sistema → Auto-cuidado / Consulta / Pronto Atendimento / Emergência`) más el **interceptor de emergencias tipo Manchester/ESI**, en `backend/src/modules/triage/services/triage-outcome.service.ts:702-718` y `mobile/lib/features/emergency/domain/red_flag_evaluator.dart:130-152`. Sin eso, el resto se arregla mayormente con copy.

---

2. Declaración de uso previsto propuesta

pt-BR

> O DualisCheckUp é um aplicativo de bem-estar e autoconhecimento. Ele ajuda você a registrar diariamente como se sente física e emocionalmente, acompanhar hábitos como hidratação e sono, visualizar seus próprios registros ao longo do tempo e acessar conteúdos educativos gerais sobre hábitos saudáveis. O DualisCheckUp não é um dispositivo médico: não avalia, não classifica nem interpreta sintomas, não indica nível de urgência, não faz diagnóstico, não recomenda tratamento e não substitui um profissional de saúde. Em caso de emergência, ligue 192 (SAMU). Se você estiver em sofrimento emocional, ligue 188 (CVV).

en

> DualisCheckUp is a wellness and self-awareness app. It helps you keep a daily journal of how you feel physically and emotionally, track habits such as hydration and sleep, view your own entries over time, and access general educational content about healthy habits. DualisCheckUp is not a medical device: it does not assess, classify or interpret symptoms, does not indicate urgency levels, does not diagnose, does not recommend treatment and does not replace a healthcare professional. In an emergency, call your local emergency number. If you are in emotional distress, contact your local crisis line.

Este texto debe ser idéntico en: Términos, onboarding, ficha de App Store / Google Play, sitio web, pitch deck, `PROJECT.md`, `CLAUDE.md` y docs de agentes. Para el regulador el uso previsto se deduce de **todos** esos materiales (MDR Art. 2(12); FDA 21 CFR 801.4 "objective intent").

---

3. Hallazgos

Convenciones: claves `.arb` citadas con su línea en `app_pt.arb`; la misma clave existe en `app_en.arb` / `app_es.arb` y debe cambiarse igual. "Hardcoded" = string pt-BR fuera de l10n (además hay que moverlo a l10n).

3.1 Lógica clínica y comportamiento (lo que realmente define la clasificación)

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
B-01	Disposición asistencial	`backend/src/modules/triage/services/triage-outcome.service.ts:702-718`	`intensity ≤2 → auto_cuidado; 3 → consulta_rotina; 4 → pronto_atendimento; 5 → emergencia`; primacía orgánica sube a consulta; `isEmergencyCandidate` fuerza `emergencia`.	Alto	REMOVE	Eliminar `careDisposi` del cálculo y de la respuesta. Ningú output individual "qué nivel de ater necesitas". Sustit por un bloque **estático igual pa todos** (ver S-03). Mantener la colur en BD solo si hay datos históricos; de escribirla.
B-02	Check-in rápido → disposición	`triage-outcome.service.ts:833-840`	`badSick ⟹ intensity=4, pronto_atendimento`; `soSo ⟹ consulta_rotina`. Un "me siento mal" se convierte en recomendación de pronto atención.	Alto	REMOVE	Guardar solo el estado auto-reportado (`bem/mai menos/mal`). Sin intensidad inferid disposición.
B-03	Interceptor de emergencias estructurado	`mobile/lib/features/emergency/domain/red_flag_evaluator.dart:130-152` (+ `triage_wizard_notifier.dart:92-103`)	Doc dice "Manchester/ESI Level 4–5 criteria … MTS Red / ESI 1"; intensidad 4 en sistemas "vitales" o 5 en cualquiera ⟹ pantalla roja bloqueante.	Alto	REFRAME	Quitar la decisión algorítmica "esto una emergencia". el usuario marca intensidad 5 (o 4 pecho/respiración urológico) mostra **aviso no bloque e idéntico para todos** con la lista estática de señale de alarma y boton 192/188 (S-02). S badges de "Dor Torácica Crítica",

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
						"Nível 4–5", sin `PopScope(canPop:false)` Eliminar referenci MTS/ESI de comentarios.
B-04	Interceptor por texto libre (regex)	`red_flag_evaluator.dart:14-60, 68`	Regex de infarto, AVC, vía aérea, cefalea en trueno, suicidio ⇒ pantalla roja con badge diagnóstico ("Suspeita de Déficit Neurológico (AVC)").	Alto (físico) / Bajo (suicidio)	REFRAME	**Suicidio/autoles KEEP** como "safe net" de contenido (práctica estánda plataformas, no e diagnóstico) **[Juic** — mostrar recurs de crisis (188/192 bloquear. **Físico:** mantener la detección solo pa disparar el **mism** aviso genérico ("S isso for uma emergência, ligue 192 agora"), nunc nombrar la condic sospechada.
B-05	IA: esquema de respuesta	`backend/src/modules/ai/services/ai-triage.service.ts:34-54`	Campos `urgencyScore` (1–5), `clinicalConcept`, `isEmergencyCandidate`.	Alto	REMOVE	Esquema nuevo: `{ isOffTopic, vertical, bodyAreaOrMood, layT mentionsSelfHarm }`. S urgencia, sin concepto médico, candidato a emergencia.
B-06	IA: prompt	`ai-triage.service.ts:111-120`	"Você é o motor de triagem médica preventiva … conceito médico formal … critérios Manchester/ESI	Alto	REFRAME	Prompt de **etiquetado de di** "Você organiza anotações de um diário de bem-est Identifique a área corpo ou o estado emocional

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
						mencionado e o termo usado pela pessoa. Não aval gravidade, não su diagnóstico nem conduta. Marque `mentionsSelfHarm` se texto mencionar desejo de se ferir morrer." Además, pasar `dto.text` como contenido separa (no interpolado) p mitigar prompt injection.
B-07	IA: aprendizaje continuo	`ai-triage.service.ts:146`, `symptom-vector.service.ts`	Cada clasificación de Gemini se inserta en la base vectorial y "aprende con el tiempo".	Medio	REFRAME	Aceptable como cache de etiqueta si se aplica B-05. alguna vez fuera dispositivo, un algoritmo adaptat exige plan de cambios predeterminado (PCCP) — otro motivo para no clasificar urgencia
B-08	Seed de conocimiento	`backend/src/modules/ai/data/symptom-knowledge.seed.ts:20-53…`	Entradas con `urgencyScore: 5`, `isEmergencyCandidate: true`.	Medio	REFRAME	Borrar los campos urgencia/emergen del seed; conserv mapeo término→área.
B-09	Primacía orgánica	`triage-outcome.service.ts:633-690`; mobile `triage_outcome_controller.dart:157,234`; `organic_primacy_banner.dart:43,53`; `triage_outcome_remote_data_source.dart:429-453`;	Razonamiento diferencial: "exigem avaliação clínica para descartar causas orgânicas	Alto	REFRAME	Eliminar el banne condicional. Si el usuario registra fí + emocional el mi día, mostrar nota estática: **"Você**

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
		triage_history_detail_modal.dart:322; .arb outcomeOrganicPrimacyTitle/Desc (app_pt.arb:924-928)	primárias", "somatização".			**registrou sensaç no corpo e nas emoções hoje. S algum desconfo físico persistir o piorar, converse com um profissi de saúde."** Sin "orgânica", "somatização", "descartar".
B-10	Escala "clínica" e intensidad "calculada"	backend/src/modules/triage/constants/intensity-tier.constant.ts:1-95 (ClinicalIntensityTier, isCritical); .arb outcomeIntensityTitle/Description (app_pt.arb:880-884); intensity_meter.dart:42,72	"Intensidade Calculada", "escala clínica de 1 a 5", tier isCritical.	Medio	REFRAME	La intensidad es **auto-reportada**; decirlo así. outcomeIntensityTitle: **"Intensidade qu você informou"**; outcomeIntensityDescr : **"Sua própria nc de 1 a 5 para co se sentiu"**. Renombrar ClinicalIntensityTier → eportedIntensityBand, quitar isCritical.
B-11	Recurrencia "crítica"	backend/src/modules/triage/services/triage-history.service.ts:423-500 (texto en :454-455, :489-490); mobile/.../critical_recurrence_card.dart; .arb criticalRecurrenceTitle (app_pt.arb:1067)	≥2 registros intensidad ≥4 en 10 días ⟹ "Foco de Atenção … desconforto severo".	Medio	REFRAME	Mantener como **insight de diario** juicio clínico. Títu **"Padrões nos se registros"**. Texto **"Você registrou {categoria} com intensidade alta vezes nos últimc 10 dias. Se isso atrapalhando se dia a dia, pode s útil conversar co um profissional saúde."** Renomb

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
						CriticalRecurrenceDto - nalPatternDto.
B-12	Antiburla: reescritura de datos	.arb antiburlaOptionRecurringDesc (app_pt.arb:970); antiburla.service.ts	"Ajustaremos o início para 'Há alguns dias' para manter seu histórico clínico consistente." El sistema "corrige" al usuario.	Bajo	REFRAME	KEEP la función como consistenci diario. Copy: **"Va registrar como a que voltou, para diário ficar organizado."** Títu antiburlaTitle: **"Isso apareceu antes?** Renombrar internamente "Antiburla" (implic fraude del usuario RecurrenceCheck.
B-13	Antiburla: frontera biológica por sexo	backend/src/modules/triage/services/antiburla.service.ts:36-48; .arb antiburlaBiologicalDiscordanceTitle/Desc (app_pt.arb:982-986)	"discordância anatômica com o seu perfil biológico. Redirecionando a avaliação…"	Medio	REFRAME	No "redirigir evaluación". Si se mantiene, solo sugerencia editab **"Quer revisar a á do corpo selecionada?"**. C riesgo de discriminación co usuarios trans/intersex (GD Art. 9, LGPD Art. no discriminación **[Juicio]**: recomie eliminar la regla.
B-14	Pantalla de emergencia bloqueante	mobile/lib/features/emergency/presentation/screens/emergency_screen.dart:87-88 (PopScope canPop:false); .arb emergencyExitButton/ExitConfirm* (app_pt.arb:195-211)	Bloquea salida; "Voltar ao Início (Não recomendado)", "Seus sintomas indicam uma situação de risco	Alto	REFRAME	Ver sección 4. Pantalla dismissa nada de "seus sintomas indicam

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
			à vida".			
B-15	Números de emergencia solo Brasil	emergency_screen.dart:175-195 (192/193/188 hardcoded)	Lanzamiento internacional con números BR.	Alto (seguridad)	REFRAME	Tabla por país (B 192/193/188; US 911/988; UE 112 línea de crisis nacional; ES 112/ PT 112/SNS24 80 24 24 24; MX 911 Fallback: 112 + "número local de emergência".
B-16	Clasificación por IA en historial/outcome	mobile/lib/features/triage_outcome/presentation/widgets/ai_insight_card.dart:27,137-138	"Informação Clínica Complementar", "Já catalogado na base clínica" + muestra aiClinicalConcept.	Alto	REMOVE	No mostrar conce médico. Si se mantiene la tarjet **"Como organiza sua anotação"** + layTerm + área.
B-17	Detección "off-topic"	.arb offTopicNarrative* (app_pt.arb:990-1002)	"Isso parece um sintoma?"	Bajo	REFRAME	**"Não entendemo bem sua anotaç "Seu texto não parece descreve como você está sentindo. Quer editar ou continuar?"**
B-18	Wizard: "Desfecho/Ação"	.planning/PROJECT.md:34 (RF-002 "Natureza → Tempo → Intensidade → Causas → Desfecho/Ação")	El paso 5 genera acción asistencial.	Alto	REFRAME	Paso 5 = **"Revisa salvar seu regist** Sin desfecho.

3.2 Copy de interfaz (`.arb` y hardcoded)

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
C-01	Onboarding	app_pt.arb:19 valueCard1Title	"Triagem Preventiva Unificada"	Alto	REFRAME	**"Diário de Bem-Estar Integrado"**
C-02	Onboarding	app_pt.arb:23 valueCard1Body	"…fluxo diário inteligente, garantindo cuidado holístico…"	Medio	REFRAME	**"Registre como você está no corpo e nas emoções em um único check-in diário de 1 minuto."**
C-03	Onboarding	app_pt.arb:27-31 valueCard2*	"Registros Médicos Blindados", "histórico clínico"	Medio	REFRAME	Título **"Seus Dado Protegidos"**; cuerpo **"Seus registros de bem estar ficam criptografados e sob seu controle, conforme a LGPD."**
C-04	Onboarding	app_pt.arb:35-39 valueCard3*	"Orientações Preventivas Precisas", "especialistas médicos renomados", "sem diagnósticos falsos"	Alto	REFRAME	Título **"Conteúdos para Hábitos Saudáveis"**; cuerp **"Leituras curtas gerais sobre son estresse, postura hidratação e mais."** ("Precisas" afirmación de exactitud no sustentada, FTC §5).
C-05	Consentimiento LGPD	app_pt.arb:43 lgpdConsentCheckbox	"…para fins de triagem preventiva e	Alto	REFRAME	**"Li e concordo com a Política de Privacidade e**

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
			acompanhamento longitudinal…"			**consinto, de form específica e destacada, com o tratamento dos meus dados pessoais sensíveis de saúde para registrar e visualizar meu diário de bem-estar, nos termos do Art. 11, I da LGPD."**
C-06	Velo privacidad	app_pt.arb:51 privacyVeilBody; hardcoded shared/widgets/privacy_veil_overlay.dart:145	"…para acessar seu prontuário."	Medio	REFRAME	**"…para acessar seus registros."** ("prontuário" es término legal del registro médico profesional, CFM 1.638/2002).
C-07	Emergencia	app_pt.arb:115-119 emergencyTitle/Subtitle	"Alerta de Risco Imediato" / "Sintomas de gravidade identificados."	Alto	REFRAME	**"Precisa de ajuda agora?"** / **"Se voc ou alguém perto de você estiver e perigo, ligue para a emergência. Nã espere."**
C-08	Emergencia	app_pt.arb:123-143 emergencyBadge*	"Dor Torácica Crítica", "Suspeita de Déficit Neurológico (AVC)", "Sintoma Crítico (Nível 4–5)"	Alto	REMOVE	Eliminar badges. Sin etiqueta de condición.
C-	Emergencia	app_pt.arb:147-191 instrucciones y	Instrucciones de primeros auxilios	Bajo	KEEP	Son información d seguridad pública

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
09		botones	genéricas, botones 192/193/188/190, buscar PS.			genérica. Revisar "Afrouxe roupas… con fuente oficial (Ministério da Saúde/SAMU) y citarla.
C-10	Emergencia	app_pt.arb:195-211	"Voltar ao Início (Não recomendado)", "Seus sintomas indicam uma situação de risco à vida…"	Alto	REFRAME	Botón **"Fechar"**; eliminar diálogo de confirmación.
C-11	Wizard banners	app_pt.arb:231-235	"Iniciando Autoavaliação Psico-Emocional/Física"	Medio	REFRAME	**"Registro emocional de hoje"** / **"Registro físico de hoje"**
C-12	Wizard preview	app_pt.arb:263, 523, 851	"Revisão da sua Avaliação…"	Medio	REFRAME	**"Revise seu registro"**
C-13	Opciones emocionales	app_pt.arb:299-323	"Depressiva / Desânimo", "Estresse / Burnout", "Somática (Psicossomática)", "Sono (Insônia / Hipersônia)", "Ansiosa / Agitação"	Medio	REFRAME	**"Pra baixo / Desanimado(a)"**, **"Estressado(a) / Esgotado(a)"**, **"Tensão no corpo"**, **"Sono ruim ou sono demais"**, **"Inquieto(a) / Agitado(a)"**. Evita términos que nombran trastorno (depresión, burnou CID-11 QD85, insomnio, hipersomnia). Renombrar keys

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
						depressive_hopelessness → low_mood, anxious_agitation → rest s, stress_burnout → stress_ haustion.
C-14	Opciones físicas	app_pt.arb:547-591	"Sistema Neurológico", "Endócrino / Metabólico", "Geniturinário / Pélvico", "Cardiovascular / Tórax", "Sistema Dermatológico"	Medio	REFRAME	Áreas del cuerpo e lenguaje lego: **"Cabeça e pescoço"**, **"Peito" "Respiração"**, **"Barriga"**, **"Costas"**, **"Braços"**, **"Pernas"**, **"Pele"**, **"Região íntima / urinária"**, **"Corpo todo / cansaço"**, **"Tontura / formigamento"**, **"Sede, fome ou energia"**. Nada de "sistema X".
C-15	Preguntas Q4	app_pt.arb:615-663	Preguntas de factores asociados (esfuerzo, pantallas, comida, medicamento…).	Bajo	KEEP	Son de contexto d estilo de vida, sin interpretación. Sol cambiar triageQ2Physical (:595) "dor ou anomalia" → **"esse desconforto"**.
C-16	Escala	app_pt.arb:864-868	"Quase imperceptível" / "Insuportável"	Bajo	KEEP	Escala de auto-reporte.
C-	Outcome título	app_pt.arb:872-876; hardcoded	"Resultado da Triagem" /	Alto	REFRAME	**"Resumo do seu registro"** / **"Um**

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
17		triage_outcome_screen.dart:33	"Avaliação preventiva baseada nas suas respostas"			**retrato do que você registrou hoje"**
C-18	Disposición	app_pt.arb:888-920; hardcoded disposition_card.dart:38-96; today_triage_summary_card.dart:35; triage_history_detail_modal.dart:46-71; retrospective_list_view.dart:35-36	"Recomendação de Cuidado", "Auto-cuidado Monitorado", "Consulta de Rotina", "Pronto Atendimento", "Atendimento de Emergência", "Nível 5 - Crítico / Emergência", "Consulta médica ambulatorial … com especialista"	Alto	REMOVE	Eliminar tarjeta de disposición y niveles "Severo/Urgente/C tico/Emergência" del historial. Reemplazar por bloque estático (S-03). En historia **"Intensidade informada: {n}/5"**
C-19	Artículos	app_pt.arb:932-936; hardcoded triage_outcome_screen.dart:180-191; today_triage_result_tab.dart:773, 793, 934, 943	"Artigos Médicos Recomendados", "elaborados por especialistas renomados", "Artigos Sugeridos para Seus Sintomas", "Recomendações clínicas selecionadas de acordo com os sintomas", "recomendadas pela equipe clínica"	Alto	REFRAME	**"Leituras sobre bem-estar"** / **"Conteúdos educativos gerais Não são orientação para o seu caso."**; **"Leituras relacionadas ao tema que você registrou"**. No "equipe clínica" si no existe.
C-20	Autores de artículos	mobile/lib/features/triage_outcome/data/triage_outcome_remote_data_source.dart:235-401 (p. ej. :373 "Psicólogo	Autores "Dr./Dra." con CRM/CRP (p. ej. "CRM-SP	**Alto**	REMOVE	**Si los autores no son reales y no firmaron el**

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
		Clínico (CRP-06/123456)"); curated_articles_catalog.dart:8-108; backend/src/modules/triage/data/medical-articles.seed.pt.ts:28-144 (+ .en, .es)	165.340", "CRP-06/123456") cuyos URLs apuntan a gov.br, drauziovarella, etc.			**contenido, es atribución falsa** (FTC §5, CDC Art. 37, normas de publicidad CFM/CFP; un número CRM inventado puede pertenecer a un médico real). Mostrar solo la **fuente real** del enlace ("Fonte: Ministério da Saúde"). Si quiere autores, contratos firmados con profesionales verificados.
C-21	Contenido de artículos	backend/src/modules/triage/data/medical-articles.seed.pt.ts:983 y similares; triage_outcome_remote_data_source.dart:314	"…exame de sangue … é capaz de diagnosticar precocemente…", "arritmias que requerem eletrocardiograma imediato"	Medio	REFRAME	Educación general está bien (wellness cat. 2 FDA) mientras no se **empareje** a la persona como recomendación. Revisión editorial: quitar imperativos clínicos personalizados.
C-22	Navegación	app_pt.arb:1396 navTodayOutcome	"Resultado do Dia"	Medio	REFRAME	**"Meu Dia"**
C-23	Historial	app_pt.arb:1027, 1039-1059	"Histórico & Tendências", "Mapa Corporal 2D", leyenda "Sem dor / Leve /	Bajo	KEEP	Visualización de datos propios = wellness/PHR. Cambiar "Sem dor → **"Sem registro"**

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
			Moderada / Intensa"			(no siempre es dolor).
C-24	Body map hints	mobile/lib/features/dashboard/presentation/widgets/anatomical_body_map.dart:51-155 (clinicalHint), :646-685	"Dispneia funcional", "Prurido", "Mialgia difusa", "Nível $intensity"	Medio	REFRAME	Lenguaje lego: **"Falta de ar, tosse"**, **"Coceira, manchas"**, **"Dor no corpo todo"**; **"Maior intensidad informada nos últimos 14 dias: {n}/5"**. Renombrar campo clinicalHint → areaHint.
C-25	Settings / historial	app_pt.arb:1280, 1288, 1372; hardcoded delete_history_item_dialog.dart:135, historical_dashboard_screen.dart:31	"histórico de triagens", "registro de triagem"	Medio	REFRAME	**"histórico de registros"**, **"este registro"**
C-26	Export LGPD	app_pt.arb:1095 exportDataDesc	"…histórico clínico…"	Bajo	REFRAME	**"…seus dados pessoais e registros de bem estar…"**
C-27	Notificación	app_pt.arb:1445 notifCheckinTitleAt	" Check-in Diário Dualis"	Bajo	REFRAME	Cambiar ☀ po .
C-28	Perfiles	app_pt.arb:1486; :1555	"Co-gestão (Pode registrar triagens)"; "Perfis de Saúde"	Bajo	REFRAME	**"(Pode adicionar registros)"**; **"Perfis"**
C-29	Dependientes	app_pt.arb:1551 addDependentLgpdArt14Consent	"…dados de saúde preventiva…"	Bajo	REFRAME	**"…dados de bem estar…"** (mantene resto).
C-30	Home	mobile/lib/features/home/presentation/screens/home_screen.dart:101	Nombre fallback **"Paciente"**	Medio	REFRAME	Fallback **"Olá!"** sin nombre. "Paciente posiciona al usuar

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
						como sujeto de atención médica.
C-31	Home	home_screen.dart:413	"Prontuário Ativo & Protegido (LGPD Art. 11)"	Medio	REFRAME	**"Seus registros estão protegidos**
C-32	Resultado del día	today_triage_result_tab.dart:84, 99, 240, 462, 670, 760	"Triagem Concluída", "Sintomas de ansiedade, sobrecarga mental ou agitação psicomotora relatados", "Atualizar Triagem de Hoje", "Completar Triagem Clínica Detalhada"	Alto	REFRAME	**"Registro concluído"**, **"Voc registrou: {opção escolhida}"** (repe palabras del usuario, no reinterpretarlas), **"Atualizar registr de hoje"**, **"Fazer registro detalhado"**
C-33	Resumen home	today_triage_summary_card.dart:96	"Triagem de Hoje Concluída"	Medio	REFRAME	**"Registro de hoje concluído"**
C-34	Login / registro	login_screen.dart:110; register_screen.dart:224	"Acesse seu prontuário e histórico de triagens preventivas"; "Informe seus dados clínicos e cadastrais para personalizar sua triagem preventiva."	Medio	REFRAME	**"Acesse seu diár de bem-estar con segurança."**; **"Informe alguns dados para personalizar sua experiência."**
C-35	Settings	settings_screen.dart:188, 373	"Avatares Clínicos"; "Seus dados clínicos permanecem	Bajo	REFRAME	**"Avatares"**; **"Seu dados permanecem seguros"**. Tambié

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
			seguros"			avatar_selector_sheet.da 27 "Clínico".
C-36	404	core/presentation/screens/not_found_screen.dart:88	"…recurso clínico…"	Bajo	REFRAME	**"A página que você tentou acessar não existe."**
C-37	Offline	triage_outcome_remote_data_source.dart:87-93, 165-171	"Sem queixas clínicas relatadas", "Avaliação clínica preliminar em modo desconectado"	Medio	REFRAME	**"Você indicou qu está bem hoje."** / **"Registro salvo n aparelho; será sincronizado."**
C-38	Wizard narrativa	triage_wizard_screen.dart:368	"Descreva como você está se sentindo com base nos sintomas..."	Bajo	REFRAME	**"Se quiser, escreva com sua palavras como você está."**
C-39	Bienestar	wellness_confirmation_dialog.dart:60	"Seu check-in preventivo diário…"	Bajo	KEEP	Cambiar solo "preventivo" → nada.
C-40	Ads	admob_banner_container.dart:37	"Parceiro Local • Zero rastreamento clínico"	Medio	REFRAME	**"Parceiro local • Anúncio não usa seus dados de saúde"**, y garantizarlo técnicamente (Apple 5.1.3; FTC HBNR).
C-41	iOS permiso	mobile/ios/Runner/Info.plist (NSFaceIDUsageDescription)	"…dados médicos confidenciais e registros de triagem."	Medio	REFRAME	**"O Dualis usa Face ID para proteger o acess aos seus registro de bem-estar."** (L ve el revisor de

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto (pt-BR)
						Apple.)

3.3 Documentos legales (mobile + backend)

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
L-01	Términos	`mobile/lib/features/privacy/presentation/screens/terms_of_service_screen.dart:105-113`	"Limitação de Responsabilidade Médica (SaMD)… estratificação de risco preventivo, **classificada conforme a Resolução RDC Anvisa nº 657/2022** e CFM 2.314/2022"	**Alto**	REFRAME	Es una **auto-declaración de SaMD**. Sustituir por: título **"2. Natureza do Serviço"**; texto = declaración de uso previsto (§2) + bullets: **"O DualisCheckUp não é um dispositivo médico e não está sujeito a registro na Anvisa."** (solo si el consultor lo confirma) / **"Não avalia sintomas, não indica urgência, não diagnostica e não recomenda tratamento."** / **"Em emergência, ligue 192 (SAMU) ou 188 (CVV)."** Eliminar toda referencia a RDC 657, CFM 2.314 y "estratificação de risco".
L-	Términos (IP)	`terms_of_service_screen.dar`	"algoritmos	Medio	REFRAME	**"software,**

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
02		t:139; backend/src/modules/legal/legal.service.ts:202	heurísticos, árvores de triagem, modelos de IA… algoritmos de triagem da plataforma"			**conteúdos, marcas e interfaces"**
L-03	Consentimiento modal	mobile/lib/features/auth/presentation/widgets/lgpd_consent_checkbox.dart:60, 78-79	"auto-monitoramento preventivo e **triagem** de bem-estar"; "Bases Normativas: Anvisa RDC 657/2022 (SaMD)… CFM 2.314/2022 (Telemedicina)"	Alto	REFRAME	Texto: declaración de §2. Bases: dejar solo **LGPD** (Art. 7, 11, 14, 18) y **CDC**. Citar RDC 657 y CFM 2.314 sugiere que el producto está bajo esas normas.
L-04	Política de privacidad	privacy_policy_screen.dart:81, 126-127, 139-143, 170-171	"dados clínicos", "Histórico Clínico Subjetivo", "**Estratificação Preventiva: Análise de sintomas** e orientações de autocuidado", "Garantia Antiburla… prevenção de adulterações", "prontuário"	Alto	REFRAME	Finalidades: **"Registro e visualização do seu diário de bem-estar"**, **"Organização automática das suas anotações por área do corpo ou emoção (com auxílio de IA, sem avaliação de saúde)"**, **"Consistência do histórico"**. Añadir encargados (Google Gemini) y transferencia internacional (ver §6).
L-	Disclaimer API	backend/src/modules/legal/legal.service.ts:70, 129, 168, 180-183, 510, 517, 543-546,	"risk stratification tools", "not an	**Alto**	REFRAME	"no es un dispositivo de

id	área	file:line	actual	riesgo	acción	cambio concreto
05		558, 565, 591-592, 603-613, 639-640	**autonomous** diagnostic medical device", "triagem clínica inteligente", "baseada em protocolos clínicos reconhecidos", "Anvisa / International SaMD Standards"			diagnóstico **autónomo**" implica que sí es un dispositivo (no autónomo). "Basada en protocolos clínicos reconocidos" es afirmación clínica. Reemplazar todo por §2 en los 3 idiomas. Eliminar `regulatoryBody: 'Anvisa / International SaMD Standards'`.
L-06	Base legal	legal.service.ts:311, 371	"Tutela da saúde… LGPD Art. 7º, VIII e Art. 11, II, 'f'"	Medio	REFRAME	Art. 11, II, "f" es "tutela da saúde, **exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**". Una app de bienestar no califica. Base correcta: **Art. 11, I (consentimento específico e destacado)**. Confirmar con DPO.
L-07	Privacidad pagos	privacy_policy_screen.dart:156	"PCI-DSS Nível 1"	Bajo	KEEP	No regulatorio; verificar que sea cierto antes de afirmarlo.

3.4 Identificadores que se filtran o que son evidencia de intención

id	file:line	identificador	riesgo	acción
I-01	mobile/lib/core/constants/api_endpoints.dart:36-44; backend/src/modules/triage/triage.controller.ts:39; triage-audit.controller.ts:23; ai.controller.ts:6,14	/v1/triage/*, /v1/triage/emergency-event, /v1/ai/classify-symptom	Bajo (visible en tráfico y para revisores)	Renombrar a /v1/journal/*, /v1/journal/safety-event, /v1/ai/tag-entry con alias temporal.
I-02	mobile/lib/core/router/route_paths.dart:7-9; app_router.dart:111-154	/triage, /triage-outcome, somaticMapping: 'Sintomas autolimitados' (app_router.dart:154)	Bajo / Medio (el último es texto visible)	/checkin, /checkin-summary; quitar "autolimitados".
I-03	mobile/lib/core/clinical/clinical_intensity_tier.dart; backend/.../intensity-tier.constant.ts	ClinicalIntensityTier, isCritical	Bajo	Ver B-10.
I-04	triage_outcome_models.dart:5, 129, 199; symptom_classification.dart:28-31	CareDisposition.emergency, aiClinicalConcept, urgencyScore, isEmergencyCandidate	Medio	Eliminar con B-01/B-05.
I-05	backend/src/database/schema/triage-emergency-events.schema.ts	tabla triage_emergency_events	Bajo	safety_resource_views (registrar solo "usuario abrió recursos de emergencia", sin diagnóstico).
I-06	Nombre del producto "Dual**is CheckUp**"	"Check-up" en pt-BR = examen médico preventivo	Medio **[Juicio]**	El nombre de tienda "Dualis" (Info.plist, AndroidManifest) está bien. En la ficha evitar "CheckUp" como promesa de chequeo médico, o añadir subtítulo "Diário de bem-estar".

3.5 Documentación interna (cuenta como evidencia de uso previsto)

id	file:line	actual	riesgo	acción
D-	CLAUDE.md (Core Value,	Todo el posicionamiento es	Alto	REFRAME con §2. Cambiar

id	file:line	actual	riesgo	acción
01	Constraints, "AI triage classification", "Level 4/5 symptoms into emergency red screen", "19-category clinical taxonomy")	triaje clínico.		"Clinical Safety" por "Safety: emergency resources always reachable".
D-02	.planning/PROJECT.md:5, 9, 20, 33-38, 73, 85-86, 99	"clinically consistent daily health triage", "100% emergency trigger fidelity", "classifies risk"	Alto	REFRAME. :73 "classifies risk and categorizes symptoms" contradice cualquier argumento de wellness.
D-03	.planning/REQUIREMENTS.md:39, 75-80, 94-96, 105	TRG-02 "formal clinical matrices", SOM-02 Organic Primacy, OUT-01 disposition, REC-01 "matched to the exact diagnosed theme", EMRG-01..03, DISC-01 "compliant with RDC 657/2022"	Alto	Reescribir requisitos conforme a B-01…B-18.
D-04	.planning/ROADMAP.md:5, 15-16, 78-97	"clinically consistent triage", Phase 3 "deterministic clinical emergency interceptor (MTS/ESI)"	Alto	Reescribir Phase 3 como "Always-on emergency resources".
D-05	.agents/agents/doctor.md:3, 29; .agents/agents/doctor/agent.md:3, 29; doctor/clinical_test_cases.json (p. ej. CASE-EMERG-001 "síndrome coronariana aguda… Exige SAMU 192"); doctor/system_prompt.md	Agente "Médico Clínico… protocolos Manchester, ESI, SUS"; casos con expectedUrgency y racional diagnóstico	Alto	Convertir en **agente de seguridad de contenido**: verifica que (a) los recursos de emergencia sean accesibles, (b) la app **no** emita urgencia/diagnóstico, (c) el copy no tenga términos prohibidos. Casos de prueba nuevos: "texto con dolor de pecho → app muestra recursos genéricos y NO nombra condición".
D-06	.agents/agents/agent-battery-report.md:14; CLAUDE.md	"Concordancia Clínica (Doctor) 11/11 (100.0%)"	Alto	Una métrica de concordancia clínica es exactamente la evidencia de desempeño de un

id	file:line	actual	riesgo	acción
	("concordancia médica")			SaMD. Eliminar; reemplazar por "tasa de copy prohibido = 0" y "recursos de emergencia accesibles en ≤1 tap desde cualquier pantalla".
D-07	.agents/agents/ai_reviewer*	Calibración de AiTriageService	Medio	Renombrar a AiTaggingService; métricas de etiquetado, no de triaje.

---

4. Seguridad de emergencia sin triaje algorítmico personalizado

Problema hoy: la pantalla roja solo es alcanzable **dentro del wizard** (emergency_controller.dart:23 → context.push(RoutePaths.emergency...), disparado solo desde triage_wizard_notifier.dart:92-103). No hay botón de emergencia en Home, historial ni settings (verificado: ninguna referencia a 192/188 en mobile/lib/features/home). O sea: el usuario solo ve ayuda si el algoritmo decide que la necesita. Eso es lo peor de ambos mundos: es triaje (regulado) y además no es accesible de forma universal.

Diseño propuesto (no personalizado, igual para todos):

1. **Botón "Ajuda urgente" siempre visible** (icono de teléfono/SOS en el AppBar o en la barra de navegación, todas las pantallas autenticadas, y en login). Abre la pantalla de recursos. Esto no depende de ningún dato del usuario → no es una función de decisión clínica.
2. **Pantalla de recursos estática** (reutilizar emergency_screen.dart sin EmergencyContext):

- Título: **"Precisa de ajuda agora?"**
- Botones según país del dispositivo (B-15): BR **SAMU 192**, **CVV 188**, **Bombeiros 193**, **Polícia 190**; buscar pronto-socorro.
- **Lista estática de sinais de alerta**, igual para todos, con fuente oficial citada (Ministério da Saúde / SAMU), p. ej.:

"Ligue 192 imediatamente se você ou alguém tiver: dor ou pressão forte no peito; falta de ar intensa; rosto torto, fraqueza num lado do corpo ou fala enrolada; a pior dor de cabeça da vida, de início súbito; desmaio ou convulsão; sangramento que não para." "Se você está pensando em se machucar ou em tirar a própria vida, ligue 188 (CVV, 24h, gratuito) ou 192."

- Dismissable (sin PopScope(canPop:false)), sin "Não recomendado", sin "seus sintomas indicam".

1. **Triggers de contexto (permitidos [Juicio])**: cuando el usuario marca intensidad 5, o 4 en pecho/respiración/cabeza, o escribe texto que coincide con las regex, mostrar **la misma tarjeta genérica** inline: **"Se isso for uma emergência, não use o app: ligue 192 agora."** + botón a la

pantalla de recursos. No se nombra condición, no se interrumpe el registro obligatoriamente, no se clasifica nivel. Es el patrón de "safety messaging" que usan buscadores y redes sociales. Mantener la regex de suicidio sin cambios funcionales (solo el copy).

2. **Offline**: la pantalla de recursos y la lista de alertas deben estar en el bundle (ya lo están las strings), funcionar sin red.
3. **Auditoría**: `triage-emergency-events` pasa a registrar solo "recursos abiertos / llamada iniciada", sin `severityLevel` ni categoría clínica (I-05). Minimiza datos (LGPD Art. 6 III).
4. **Nunca detrás de paywall** (Phase 15 tiers).

Lo que se pierde: el "interceptor zero-failure" como promesa. Eso es intencional: prometer fidelidad del 100% en detectar emergencias **es** una afirmación de desempeño clínico. La promesa nueva es "ayuda a 1 toque desde cualquier pantalla".

---

5. Impacto en el roadmap

Fase / feature	Veredicto	Detalle
Phase 3 (Emergency Risk Alert)	REFRAME	Ver §4. Re-especificar como "Always-on Safety Resources".
Phase 4–7, 9 (wizard, home, outcome, antiburla, dashboard)	REFRAME	Aplicar B-01…B-18 y copy de §3.2. El wizard de 5 pasos y el mapa corporal sobreviven como **diario**.
Phase 11 (multi-perfil / dependientes)	KEEP	Revisar COPPA (EE. UU., <13), GDPR Art. 8 (edad de consentimiento por país), LGPD Art. 14. Curatela de adulto "enfermo/dependiente" (REQUIREMENTS `:120`) — copy sin "enfermo".
Phase 12 — Carteira de vacinação	KEEP	Registro personal = PHR (no MD: MDCG 2019-11 "almacenamiento/archivo"; FDA PHR). Recordatorios de refuerzo: solo si vienen del calendario oficial publicado (PNI) mostrado tal cual, sin cálculo personalizado por condición.
Phase 12 — Alergias **con verificación cruzada**	REMOVE el cross-check / KEEP el registro	"Automated warnings if a logged symptom or medication conflicts with a registered drug allergy" (ROADMAP Phase 12 criterio 3) es una función de detección de interacción/alergia = MDSW (UE IIa+, FDA device). Mantener solo la lista de alergias que el usuario escribe y muestra en su perfil/export.
Phase 13 — Condiciones	KEEP	Que el usuario anote diagnósticos **que ya le dio su médico** es

Fase / feature	Veredicto	Detalle
CID-10/11	(reframe)	PHR. Nombrar la pestaña **"Minhas condições (informadas por você)"**, no "Prontuário Estruturado". No sugerir códigos CID a partir de síntomas.
Phase 13 — Alarmas de medicamento y stock	KEEP	Recordatorio de lo que el usuario configuró = no MD (FDA lo lista como no-device/enforcement discretion; MDCG trata recordatorios simples como no MDSW). Sin ajuste de dosis automático.
Phase 13 — PDF "Doctor's Brief" SBAR	REFRAME	SBAR incluye **Assessment** y **Recommendation**: generaría juicio clínico. Exportar **"Resumo dos meus registros"**: datos tal como se registraron (fechas, intensidades auto-reportadas, notas, medicación y alergias informadas). Sin secciones A/R, sin interpretación.
Phase 14 — OCR de exámenes / biomarcadores	REFRAME o PARTNER	Transcribir y archivar = aceptable **si**: (a) el usuario confirma cada valor, (b) se muestra el rango de referencia **impreso por el laboratorio**, (c) **sin** colores normal/alterado, alertas, tendencias interpretadas ni comentario de IA. Cualquier interpretación ("glicemia alta", "PSA elevado") = MDSW (UE IIa+; FDA device; ANVISA). Si el negocio necesita interpretación → **socio regulado** (laboratorio o plataforma con registro ANVISA/CE) o producto separado.
Phase 14 — Lector de receta → agenda de dosis	REFRAME (alto riesgo)	Un error de OCR que crea una dosis equivocada es daño directo. Solo pre-llenar formulario editable, confirmación obligatoria campo por campo, nunca crear alarmas automáticamente. **[Juicio]**: recomiendo posponer hasta tener consultor; la línea entre "transcripción" y "gestión de medicación" es fina.
Phase 14 — Resumen de bula con IA (5 puntos: posología, contraindicaciones, efectos, dosis olvidada)	**REMOVE / PARTNER**	IA generativa resumiendo posología y contraindicaciones = información de medicamento derivada, con riesgo de alucinación en dosis. En BR además roza la regulación de información de medicamentos. Alternativa: enlazar al **Bulário Eletrônico de ANVISA** (texto oficial, sin reescritura) o licenciar contenido de un proveedor de información farmacológica regulado.
Phase 15 — Voz	REFRAME	"Voice triage" → **"registro por voz"**. Misma lógica de diario. Si la voz se usa para identificar/autenticar = dato biométrico

Fase / feature	Veredicto	Detalle
		(GDPR Art. 9, LGPD Art. 5 II). No guardar audio salvo necesidad.
Phase 15 — Biometría avanzada	KEEP	Seguridad, no clínica.
Phase 15 — Suscripciones	KEEP	Ficha de tienda y paywall sin promesas clínicas ("Advanced: interpretación de exámenes" sería claim de MD). Recursos de emergencia gratuitos siempre.
AdMob (RF-009 / AD-01)	KEEP con condiciones	Hoy es placeholder sin SDK. Al integrar: solo anuncios contextuales, ningún dato de salud a la red publicitaria (Apple 5.1.3, Google Play, FTC HBNR — casos GoodRx/BetterHelp). Evitar anuncios de farmacia junto a registros de síntomas **[Juicio]**.

---

6. Obligaciones de datos que permanecen aunque sea wellness

Ser wellness **no** reduce la categoría de los datos: síntomas, estado emocional y condiciones siguen siendo datos de salud.

Brasil (LGPD)

- **Art. 11, I**: consentimiento específico y destacado para datos sensibles. Corregir base legal (L-06).
- **Art. 14**: datos de niños/adolescentes con consentimiento de un responsable; mejor interés.
- **Art. 33**: **transferencia internacional**. El backend llama a Gemini por **API key** (`backend/src/common/ai/gemini.service.ts:8-14`, modelo por defecto `gemini-2.5-flash` en `:5`, no 1.5 como dice `CLAUDE.md`), es decir, la **Gemini Developer API**, no Vertex AI en `southamerica-east1`. La narrativa del usuario sale de Brasil. Esto **contradice** la promesa de residencia en São Paulo (`.planning/PROJECT.md:28`, política de privacidad). Acciones: migrar a Vertex AI con región BR/UE o declarar la transferencia + cláusulas contractuales (Res. CD/ANPD 19/2024).
- **Riesgo adicional**: en el nivel **gratuito** de la Gemini Developer API, Google puede usar el contenido para mejorar productos. Confirmar que se usa nivel de pago / Vertex con no-entrenamiento y DPA firmado. Si no, es divulgación no autorizada de datos de salud.
- **Art. 37–38**: registro de operaciones y **RIPD** (informe de impacto) — obligatorio en la práctica para datos sensibles a escala.
- **Art. 41**: encargado (DPO) publicado.
- **Art. 48** + Res. CD/ANPD 15/2024: comunicar incidentes a la ANPD y titulares (plazo de 3 días hábiles).
- **Art. 18**: derechos (export y borrado ya implementados en Phase 10 — KEEP).

UE (GDPR)

- **Art. 9(2)(a)**: consentimiento explícito para datos de salud.
- **Art. 8**: edad de consentimiento digital (13–16 según país) para dependientes/menores.
- **Art. 35**: DPIA obligatoria (datos de salud a gran escala + IA).
- **Art. 27**: representante en la UE si no hay establecimiento.
- **Art. 28 / 44-49**: DPA con Google y cualquier encargado; mecanismo de transferencia (BR no tiene adecuación UE).
- **Art. 33-34**: notificación de brechas en 72 h.
- **Art. 22**: evitar decisiones automatizadas con efectos significativos (otra razón para quitar la disposición asistencial).
- AI Act **Art. 50**: si hay interacción conversacional (voz, Phase 15), informar que es IA.

EE. UU.

- **FTC Health Breach Notification Rule** (16 CFR 318, enmienda 2024): la app es un vendor de PHR. "Breach" incluye compartir datos sin autorización (SDKs de analítica/ads, IA de terceros que entrene con ellos). Notificar a individuos, FTC (y medios si >500 en un estado) en ≤60 días.
- **FTC Act §5**: claims de salud con sustento (C-04 "Precisas", C-20 autores).
- **Leyes estatales de datos de salud del consumidor**: Washington **My Health My Data Act**, Nevada SB 370, Connecticut (CTDPA) — consentimiento separado para recolectar y para compartir, prohibición de geofencing alrededor de centros de salud. Relevante para AdMob con "geolocalización aproximada" (REQUIREMENTS :41).
- **COPPA**: perfiles de menores de 13 años (Phase 11).
- HIPAA: probablemente **no** aplica (no hay covered entity) **[Juicio]**; deja de ser cierto si se integra con prestadores/planes de salud.

Tiendas

- Apple: privacy nutrition label con "Health & Fitness", 5.1.1(ix) apps altamente reguladas, 5.1.3 sin uso de datos de salud para publicidad ni venta.
- Google Play: Health apps declaration, Data safety form, política de datos sensibles.

---

7. Plan de acción ordenado

#	Acción	Hallazgos	Esfuerzo
1	**Detener la publicación de autores con CRM/CRP no verificados**; mostrar solo fuente real del enlace.	C-20	S
2	Reescribir Términos, consentimiento, política de privacidad y disclaimer del backend con la declaración de §2; quitar toda referencia a RDC 657, CFM 2.314, "estratificação de risco", "protocolos clínicos",	L-01…L-06, C-05	S

#	Acción	Hallazgos	Esfuerzo
	"não autônomo"; corregir base legal a Art. 11, I.		
3	Copy de interfaz pt/en/es: onboarding, outcome, home, historial, settings, login/registro, Info.plist, "Paciente", "prontuário", "triagem" → "registro". Mover hardcoded a l10n.	C-01…C-41	M
4	Botón "Ajuda urgente" siempre visible + pantalla de recursos estática dismissable + lista estática de sinais de alerta + números por país.	§4, B-14, B-15, C-07… C-10	M
5	Quitar disposición asistencial (backend + mobile + historial) y reemplazar por bloque estático: **"Este app não avalia sua saúde. Se algum desconforto persistir, piorar ou te preocupar, procure um profissional de saúde. Em emergência, ligue 192."**	B-01, B-02, C-18	M
6	Cambiar esquema y prompt de Gemini a etiquetado de diario; eliminar `urgencyScore`/`clinicalConcept`/`isEmergencyCandidate` en seed, DTOs y UI.	B-05…B-08, B-16, I-04	M
7	Convertir interceptor estructurado y regex físicas en aviso genérico no bloqueante; mantener safety net de suicidio con nuevo copy.	B-03, B-04	M
8	Primacía orgánica → nota estática; recurrencia crítica → "Padrões nos seus registros"; intensidad "calculada" → "informada"; antiburla copy y eliminar regla por sexo.	B-09…B-13	S–M
9	Gemini: Vertex AI en región adecuada o transferencia declarada; confirmar no-entrenamiento + DPA. RIPD/DPIA.	§6	M
10	Reescribir `CLAUDE.md`, `PROJECT.md`, `REQUIREMENTS.md`, `ROADMAP.md`, agente doctor y métricas de batería (quitar "concordancia clínica").	D-01…D-07	M
11	Renombrar identificadores (`/triage` → `/journal`, `ClinicalIntensityTier`, tabla de eventos) con alias de compatibilidad.	I-01…I-05	L
12	Roadmap: quitar cross-check de alergias (P12), SBAR sin A/R (P13), OCR solo transcripción confirmada y bula vía Bulário ANVISA o partner (P14), voz como registro (P15).	§5	S (decisión) / L (ejecución)
13	Revisión por consultor regulatorio (BR/UE/US) con este documento +	Todos	— (externo)

#	Acción	Hallazgos	Esfuerzo
	build reescrito; preparar ficha de tienda alineada a §2 y respuesta a revisión 1.4.1.		

Orden lógico: 1-3 se pueden hacer en una semana y ya eliminan la mayor parte de la evidencia escrita de uso médico. 4-8 cambian el comportamiento que hoy define la clasificación; sin ellos, cambiar el copy no basta (el regulador mira lo que el software **hace**, no solo lo que dice). 9 es independiente del estatus wellness y obligatorio igual.

Decisión de negocio que queda abierta: si la propuesta de valor central es "decirle al usuario qué tan urgente es lo que siente", eso no cabe en wellness en ninguna de las tres regiones. La alternativa es lanzar el diario de bienestar ahora y desarrollar el triaje como producto regulado separado (o con un socio que ya tenga registro ANVISA / marcado CE / autorización FDA).